

QCM Médecine interne

Q1 : Patient de 75ans, FA depuis 2 ans, fréquence ventriculaire 72/min. Pas d'oppression thoracique ni d'essoufflement, pas d'OMI. TA normal, ne prend aucun médicament.

- Beta-bloquant
- Dérivé de la coumarine (anti-coagulant) – Vrai :
- Digoxine
- Agrégation plaquettaire avec Aspirine
- Electrocardioversion

CHADVASC 3 ?

TT :

- Sintron : car on connaît bien, on maîtrise bien, on a des antidotes faciles et puissant
- ACOD : Dabigatran, Rivaroxaban, apixaban...

Risque thrombo-embolique = pour FA et flutter auriculaire (mais ici le + souvent on tente une ablation).

Rythm vs rate control : de base le traitement de la FC suffit, mais récemment il y a eu une étude qui privilégie la cardioversion dans le cas d'une FA d'apparition récente et sans CI.

Cardioversion : seulement après 1 mois d'anti-coagulation, exception = instabilité hémodynamique, dans ce cas il faut exclure un thrombus (à l'US ?)

Q2 : 42 ans, fièvre, sudations nocturnes, perte pondérale, toux depuis 1 mois. Incarcéré brièvement il y a 10 mois en raison d'usage de drogues. HIV neg. Examen direct des expecto : nombreux BAAR (bacilles acido-alcolo-résistants). Rx du thorax (complexe de Ghon ?). TT :

- Isoniazide, pyrazinamide, ethambutol et rifampicine

TBC, diagn : PCR dans les expectorations (permet de montrer la R à la rifampicine et l'isoniazide), culture (3-6 semaines) et antibiogramme

Durée prolongée : en cas de méningite (12 mois) et de spondylodiscite (9mois). Toujours ajouter des stéroïdes dans la méningite.

Co-infection TBC et HIV : on introduit d'abord tt TBC, puis 2-8 semaines plus tard le tt anti-viral

Q3 : 45 ans, transplanté rénal depuis 2 ans, suivi par quantiferon 1x/an. Jusqu'alors quantiféron neg, actuellement positif. Rx thorax normal. Que faire ?

- Pas de ttt, répéter le test de Mantoux dans 6 semaines
- Pas de tt, répéter les Rx du thorax
- TT pour TBC latente – Vrai
- Quadrithérapie anti-tbc – Faux
- Diminuer le régime immunosupp

Q4 : lors d'un examen d'entourage d'une famille effectué après découverte d'un cas de TBC, un enfant de 7 ans a un quantiferon positif. N'a pas eu de BCG. Rx thorax normal. Mesure :

- Isoniazid pendant 9 mois – Vrai : tt pour la TBC latente, diminue de 90% l'apparition d'une TBC maladie, indications : situation clinique (ex : contage) + quantiféron positif et Rx de thorax normal. Aussi possible Isoniazide + rifampicine (3 mois) ou rifampicine (4 mois).
- Tri-thérapie (isoniazide, ethambutof et rifampicine) - Faux : ttt pour TBC active
- Vacciner par le BCG

- Rx de contrôle dans 6 semaines

On traite aussi un enfant < 5 ans avec contagé (indépendamment du test quantiféron), si > 5 ans et contagé il faut test du quantiféron pos.

Quantiféron = dosage de la production d'IFN après stimulation des leucocytes par Ag de tuberculosis. Reste positif à vie normalement.

Test de Mantoux est moins sensible : injection de l'Ag de tuberculine sous la peau → induration et œdème.

Perturbations des tests hépatiques : on tolère 5-10x transaminases, si trop, on diminue la rifampicine, ev. remplacer par d'autres tt.

Q5 : 60 ans, méningite lymphocytaire (300 cell mononuclées dans le LCR). Après 4j, il développe une diplopie. Parésie du muscle abducteur D. Quel micro-organisme ?

- Borrelia burgdorferi (maladie de Lyme)
- Treponema pallidum (syphilis)
- Mycobacterium tuberculosis – Vrai : méningite avec atteinte des NC (15-30%), méningite lymphocytaire (comme les méningites virales), méningite chronique sur plusieurs semaines, mortalité élevée avec tt.
- Coxiella burnetti (fièvre Q)
- Brucella abortus

Maladie de Lyme :

- Stade 1 : état pseudo-grippal, rash, érythème migrant
- Stade 2 : forme disséminée (cutanée, neuro, encéphalite, polyneuropathie, cardiaque)
- Stade 3 : arthrite, neuroborréliose

Il existe un vaccin contre l'encéphalite à tique.

Q6 : 74 ans, céphalées brusques, vomissement et frissons. Somnolent, flasque, fébrile à 40.5 degrés, respiration profonde, lente et râlante. TA 140/80, pouls régulier à 98 bpm. Examen le + urgent (déterminant pour le diagn) :

- FSC
- Hémocultures
- Examen complet des urines
- Rx thoraciques
- PL

Suspicion de méningite bactérienne :

- ATB empirique : ceftriaxone +
 - o Corticostéroïdes : S. Pneumoniae
 - o Amoxicilline : Listeria
 - o Acyclovir : HSV, VSV
- FO : œdème papillaire indique une HTIC et CI la PL
- PL : cellularité, répartition leucocytaire (Viral et TBC → Lymphocytes ; Bactérien → neutrophiles), protéines
- Hémocultures
- CT avant PL si atteinte neurologique franche (notamment latéralisation), situation où on pense qu'il y a engagement...

Q7 : 19 ans, syndrome néphrotique, médecin commence un traitement par des glucocorticostéroïdes. Oedèmes diminuent et le poids baisse. Subitement, le malade ressent des douleurs intenses dans la loge rénale D et sous le rebord costal D, latéralement. Doit rester assis, ne peut plus se coucher sur le dos. Forte protéinurie. Diagn :

- Crise de lithiase rénale – Faux : pas lié au sy néphrotique
- Cholécystite aiguë
- Thrombose de la veine rénale – Vrai : complication fréquente du sy néphrotique = thrombo-embolisme.
- Appendicite aiguë
- EP

Sy néphrotique

- Protéinurie > 3g/24h
- Hypoalbuminémie < 30g/l
- Œdème

Calcul de la protéinurie : rapport $U_{prot} \times 8.84 / U_{creat}$.

Pur en absence d'hématurie, HTA, IR.

Complications :

- IRA
- Thrombose veines rénales
- Hypercoagulabilité : lié à la fuite de l'AT III, augmentation compensatrice de la synthèse hépatique de protéines pro-coagulantes (si Albumine < 20g/l dans le sang, on met un tt anti-coagulant préventif)
- Risque infectieux
- Hyperlipidémie
- HTA
- Dénutrition

Sy néphritique : glomérulonéphrite aiguë (ex : vasculite), arrive brutalement

- IRA
- HTA
- Hématurie
- Protéinurie < 3g/24h

Q8 : Quelle affection n'est pas une cause de sy néphrotique ?

- Glomérulonéphrite membranaire
- Lupus érythémateux disséminé
- Amyloïdose
- Diabète
- Pyélonéphrite – Vrai

Q9 : 24 ans, toxicomane IV, se plaint d'un état subfébrile, inappétence progressive, dorsalgies depuis 5j. Etat général diminué, céphalées, mais pas de méningisme. T 38.8, TA 95/60, 98 bpm. Hypoesthésie au bord latéral du pied G. Percussion de la colonne vertébrale est douloureuse. Labo : leuco 16G/l, hémoglobine 6.4, thrombocytes 426.

Investigation ?

- IRM colonne lombaire – Vrai, CT moins bon pour abcès et lésions précoces.
- Rx conventionnelle de la colonne
- Recherche FR

- PL

Suspicion : spondylodiscite, ostéomyélite

Suspicion également d'endocardite, donc à voir hémoch et ETT.

Q10 : 12 j après retour de vacances au bord de la méditerranée, homme de 25 ans présente température élevée, frissons et céphalées. Diarrhées puis constipation opiniâtre. Rate palpable. T 39.8 degrés, 72 bpm. Leuco 5.2, Hb 135 g/l. Diagnostic :

- Leptospirose
- Amibiase
- Fièvre typhoïde – Vrai : présentation clinique typique = fièvre, splénomégalie, taches roses, dissociation sphygmo-thermique. Surtout en Asie. De + en + de souches résistantes (aux quinolones), implication sur le tt : azithromycine en 1^{er} choix (ceftriaxone en 2^e choix)
- Malaria
- Entérite à staphylocoques

Q11 : Dyspnée croissante et somnolence diurne chez homme de 55 ans, obèse, cyanose centrale, auscultation cardio pulm sp, Rx thorax normal. VEMS 78%, Gazo : 7.37, hypoxémie hypercapnique, bic 20. TT :

- Bronchodilatateurs longue durée en inhalation
- Thérapie systémique d'acétazolamide
- Thérapie systémique de corticoides
- VNI à pression positive et nocturne – Vrai : car tt de l'hypercapnie
- Oxygénothérapie de 16 à 24h

Q12 : 50 ans, fumeur, tousses et crache depuis 1 an, pas de fièvre, pas de perte de poids, pas d'allergie, pas de RGO. Rx thorax normal. VEMS 85%, VEMS/CVF 75%, pas de changement après bronchodil. Diagnostic :

- Asthme
- Risque pour BPCO – Vrai : le diagn de BPCO c'est VEMS/CVF < 70% ou VEMS/CVF < limite inférieure de la norme.
- BPCO léger (stade I)
- BPCO modéré (stade II)

Q13 : 78 ans, perte progressive de la mémoire, diminution de la concentration, labilité affective, ataxie, incontinence.

- Maladie d'Alzheimer : peu d'atteinte de la marche
- Hydrocéphalie à pression normale : Vrai, tt : shunt ventriculo-péritonéal
 - o Troubles de la marche
 - o Troubles cognitives
 - o Incontinence urinaire
- Déficit en vit B12 : surtout atteinte sensitivo-moteurs
- Démence sur accident vasculaires multiples : aggravation par étapes
- Neurosyphilis : peut tout mimer

Bilan démence : bilan neuropsych, dosage vitamines, imagerie

Q14 : 30 ans, fièvre depuis 4j avec toux non productive. Râles fins à la base du poumon D. Rx : infiltration mal délimitée dans le lobe inférieur D. Leuco 8.4G, neutrophiles 70%. Le patient ne peut pas produire d'expecto. TT :

- Ceftriaxone
- Amoxicilline – Vrai : pour patient jeune < 50ans sans comorbidités
- Clarithromycine + co-amox
- Norfloxacin
- Cotrimoxazole

Co-amox = augmentin. Clarithromycine pour couvrir légionnelle et mycoplasme. Si allergie à la pénicilline : levofloxacin (couvre tout : germes typiques et atypiques)

Q15 : Patiente sans passé pulmonaire, 7j après anesthésie générale, fièvre, toux avec expectorations fétides, grises. Rx du Thorax (abcès avec niveau hydro-aériques). Pathogènes :

- Candida Albican
- Mycoplasma pneumoniae
- Anaérobies – Vrai : risque de bronchoaspiration
- Staph doré - Pas exclu, mais le + souvent diffusion hématogène, partout dans le poumon.

Germes qui font des abcès : aspergillose, TBC, S. aureus.

Q16 : 72 ans, maladie coronarienne, 4j après coronarographie en raison de l'apparition de couleurs de 2 avants-pieds, de zones réticulaires de coloration rouge-bleutée au niveau de l'abdomen et des jambes, confluentes au niveau des orteils. = Syndrome des embolies de cholestérol/Blue toe syndrome : 9/10 après un geste invasif artériel. On s'attend à trouver :

- Eosinophiles > 700
- CRP élevée
- Hématurie et IR



Très difficile à traiter, tt par aspirine.

Q17 : 65 ans, vertiges intermittents, capacité physique réduite. TA 140/80, 42 bpm. ECG montre un rythme sinusal. Sur le cyclomètre il peut réaliser 100 watts, mais après 3 minutes, il s'arrête essoufflé avec un pouls maximal de 50/min et la tension à 170/90 mmHg.

De quoi s'agit-il le plus vraisemblablement?

- Hypothyroïdie
- Maladie du nœud sinusal – Vrai : le + souvent médicaments
- Bloc AV
- Vagotonie constitutionnelle
- Manque d'entraînement

Q18 :